TUMORES MALIGNOS DE MAMA

DR. PABLO DURAN

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

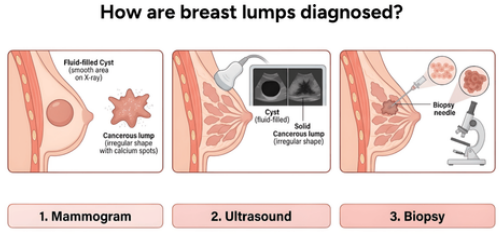
- 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama; la detección temprana salva vidas.
- Factores de riesgo: sexo femenino (100:1 vs hombres), edad (promedio 65 años), riesgo genético (5-10%, BRCA1/BRCA2), cáncer previo en la otra mama, radiación en el pecho, hormonas posmenopáusicas, mamas densas.
- Factores genéticos: 10-20% de los cánceres de mama son hereditarios; 7% por mutaciones en BRCA1/2 (síndrome HBOC).

BRCA1 Y BRCA2

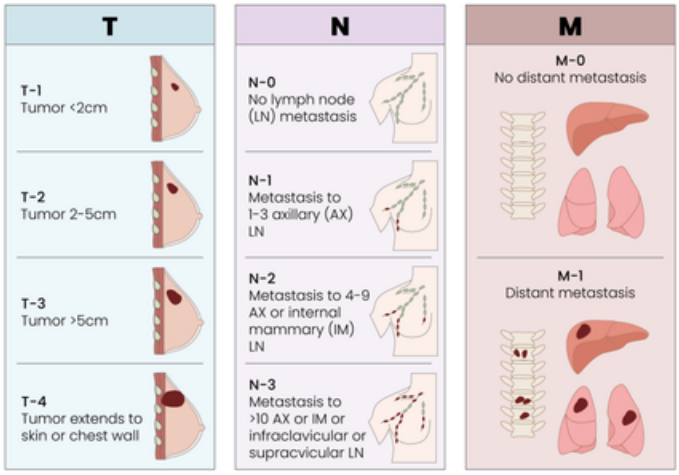
- BRCA1: gen supresor de tumores; 50-84% de riesgo de cáncer de mama a los 70 años, y 25-44% de riesgo de cáncer de ovario a los 60.
- BRCA2: riesgo menor de cáncer de mama; mayor riesgo de cáncer de próstata en hombres y de páncreas.
- Prevención en portadoras: mamografía anual (25-35 años), examen clínico cada 6 meses, quimioprevención con tamoxifeno, y mastectomía/ooforectomía profiláctica en casos seleccionados.

DETECCIÓN TEMPRANA

- Autoexamen mensual y examen clínico anual complementan la mamografía; no la sustituyen.
- Mamografía de tamizaje: generalmente anual o bianual a partir de los 40-50 años según el riesgo individual.
- Signos de alarma: nódulo nuevo, retracción de la piel o el pezón, secreción sanguinolenta, cambios en el tamaño o la forma de la mama.



ESTADIFICACIÓN TNM



CARCINOMA DUCTAL IN SITU

- Confinado a la membrana basal; no metastatiza a ganglios: no requiere quimioterapia ni vaciamiento axilar.

CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU

- No es un cáncer verdadero: marcador premaligno de riesgo bilateral.

CARCINOMAS INVASORES

- Ductal invasor (el más frecuente) y lobulillar invasor.

CARCINOMA INFLAMATORIO

- Eritema, calor, edema y piel de naranja por émbolos en linfáticos dérmicos (T4d): quimioterapia neoadyuvante antes de la mastectomía.

SUBTIPOS MOLECULARES

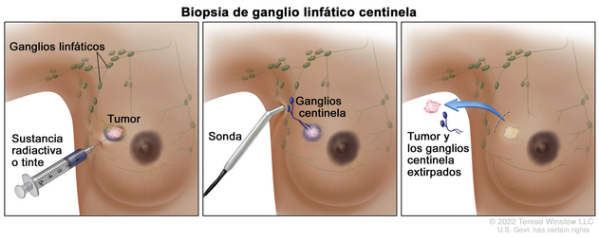
- Luminal A/B (receptores hormonales positivos): generalmente mejor pronóstico; tratamiento con hormonoterapia.
- HER2 positivo: tratamiento dirigido anti-HER2 (ej. trastuzumab) además de quimioterapia.
- Triple negativo: sin receptores hormonales ni HER2; más agresivo, depende principalmente de quimioterapia.

TUMORES MALIGNOS DE MAMA

DR. PABLO DURAN

GANGLIO CENTINELA

- Tecnecio-99 y/o azul patente; si es negativo se omite el vaciamiento axilar y se previene el linfedema del brazo.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y SISTÉMICO

- Cirugías: mastectomía radical modificada, mastectomía parcial con biopsia del ganglio centinela, o mastectomía con preservación de piel/areola/pezón con reconstrucción inmediata (implante, TRAM, DIEP).
- Quimioterapia neoadyuvante (antes de cirugía): ayuda a disminuir el tamaño del tumor y permite preservar la mama; la sobrevida es similar a la adyuvante.
- Quimioterapia adyuvante (después de cirugía): se basa en el subtipo molecular y el riesgo de recurrencia.

CIRUGÍA DEL CÁNCER DE MAMA

